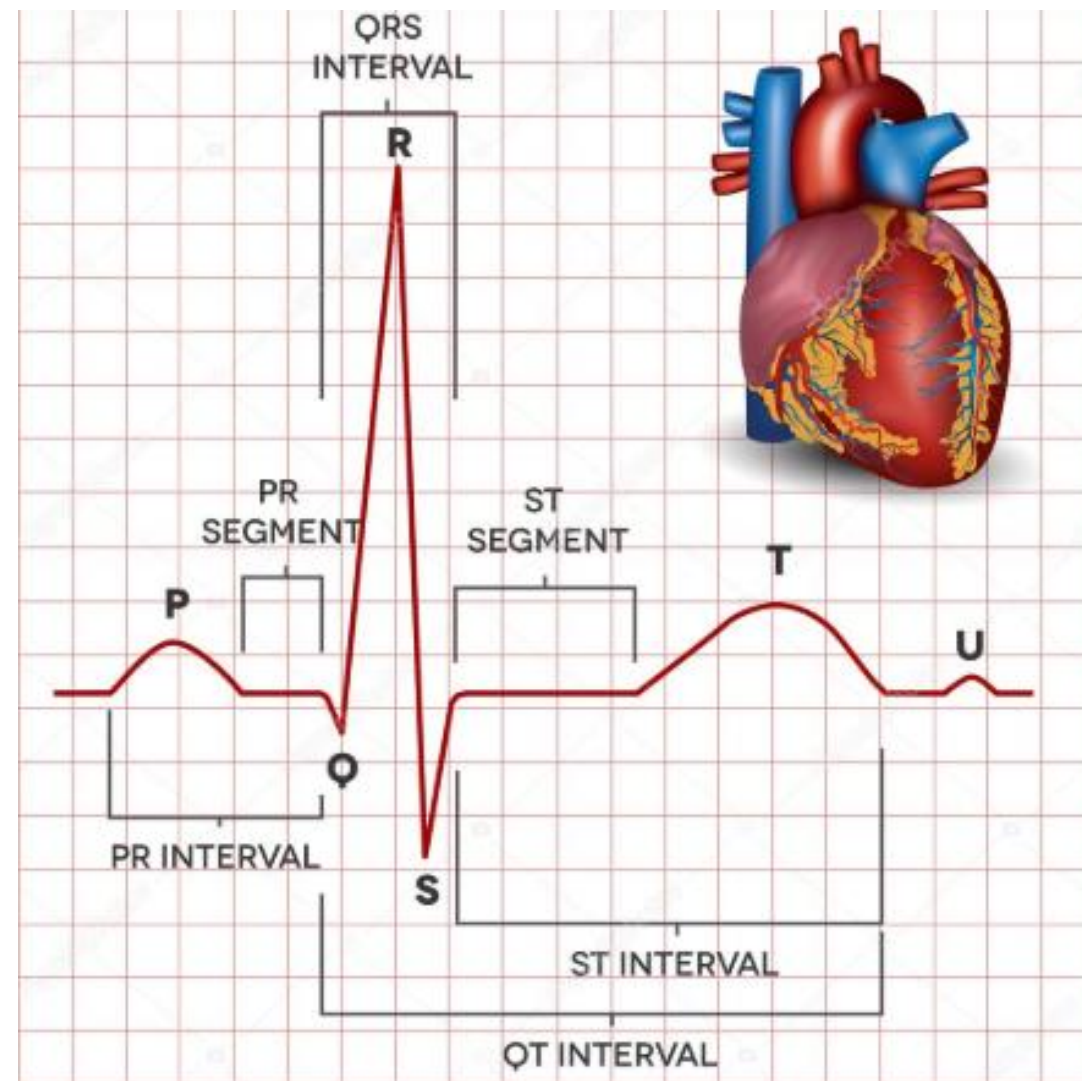
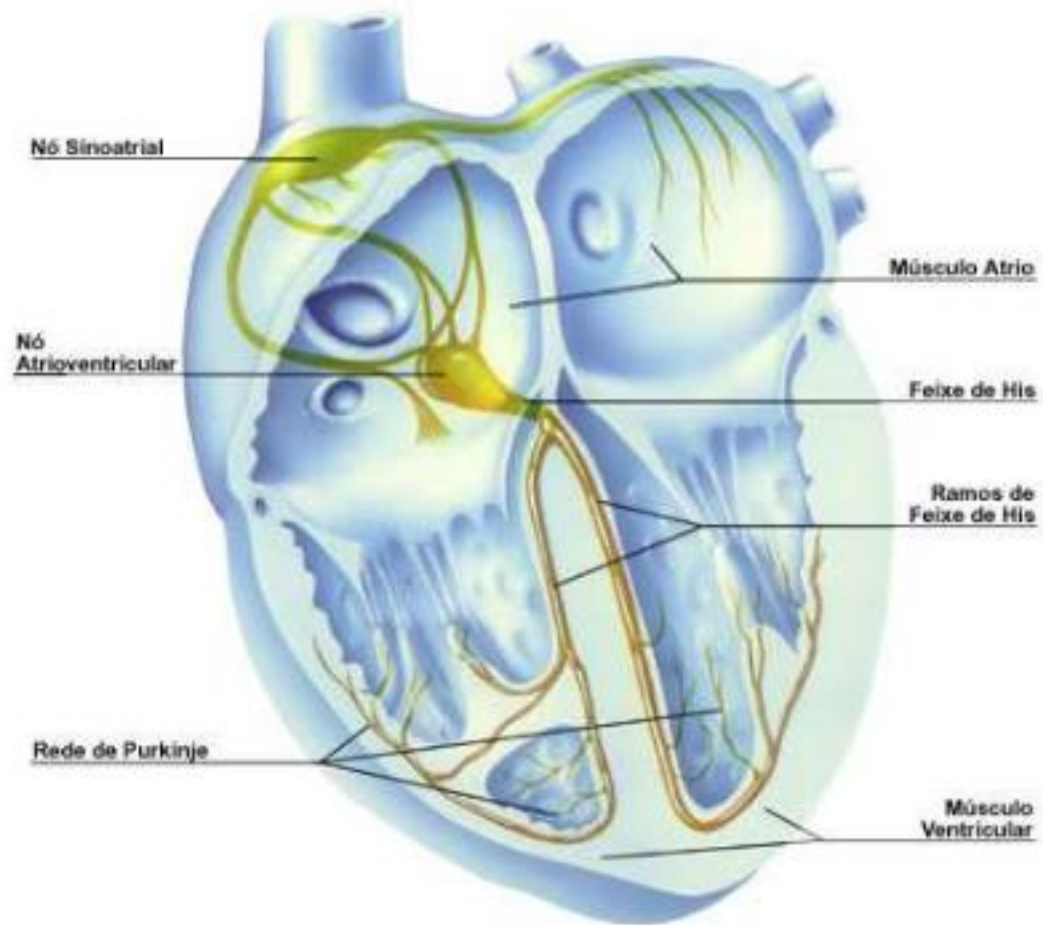


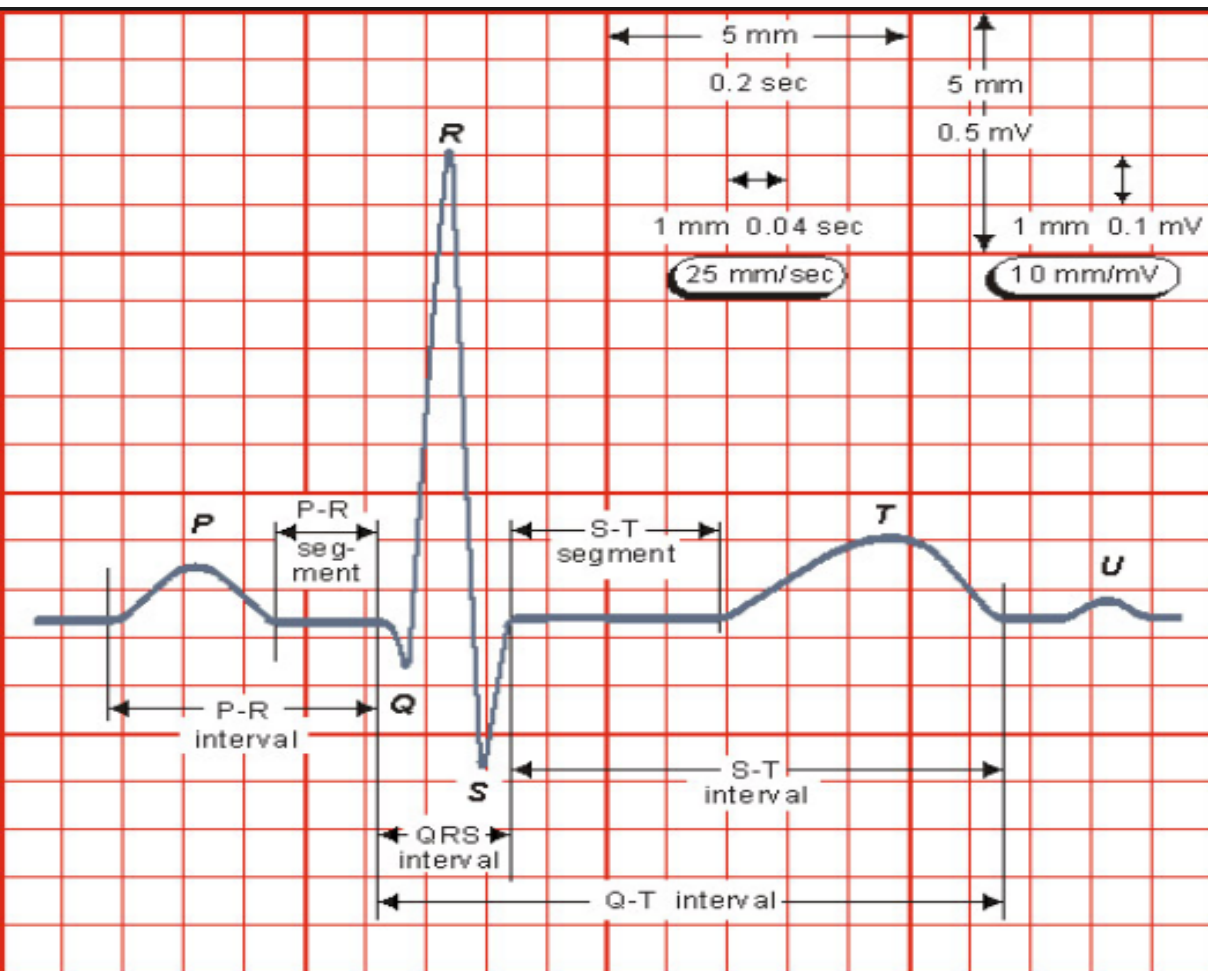
BRADIARRITMIAS

Professor Eurípedes Ferreira Araújo Mendes

- ✓ Graduação em medicina – UFPI
- ✓ Residência de Clínica médica – Hospital Santa Marcelina -SP
- ✓ Residência Cardiologia – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia -SP
- ✓ Título de Especialista em Cardiologia pela SBC – AMB
- ✓ Especialização em eletrofisiologia não invasiva e estimulação cardíaca artificial – Inst. Dante Pazzanese de Cardiologia – SP
- ✓ Membro Habilitado pelo Depart. de estimulação cardíaca artificial – DECA SBCCV
- ✓ Título de especialista na área de atuação estimulação cardíaca eletrônica artificial – Sobrac / ABEC DECA
- ✓ Professor do curso de medicina da uninovafapi



ECG NORMAL



- ❖ Onda P: 80 -110ms - 2,5mm
- ❖ Intervalo PR: 120 – 200ms – 3 a 5 mm
- ❖ Complexo QRS: 60 – 110 ms – até 2,5 mm
- ❖ Segmento ST: ponto J - desnivelamentos 1 mm
- ❖ Intervalo QT: 350 – 440 =>
 - 460ms mulheres - 470ms homens
- ❖ Onda T : 30% QRS ou abaixo de 6mm

Frequência cardíaca normal

FC 50 – 100 bpm

Artigo publicado no
JOURNAL OF
ELECTROCARDIOLOGY 2007.

79.743 pacientes
ambulatoriais – observado
na distribuição gaussiana
variações da frequência
cardíaca entre 48 – 98 bpm

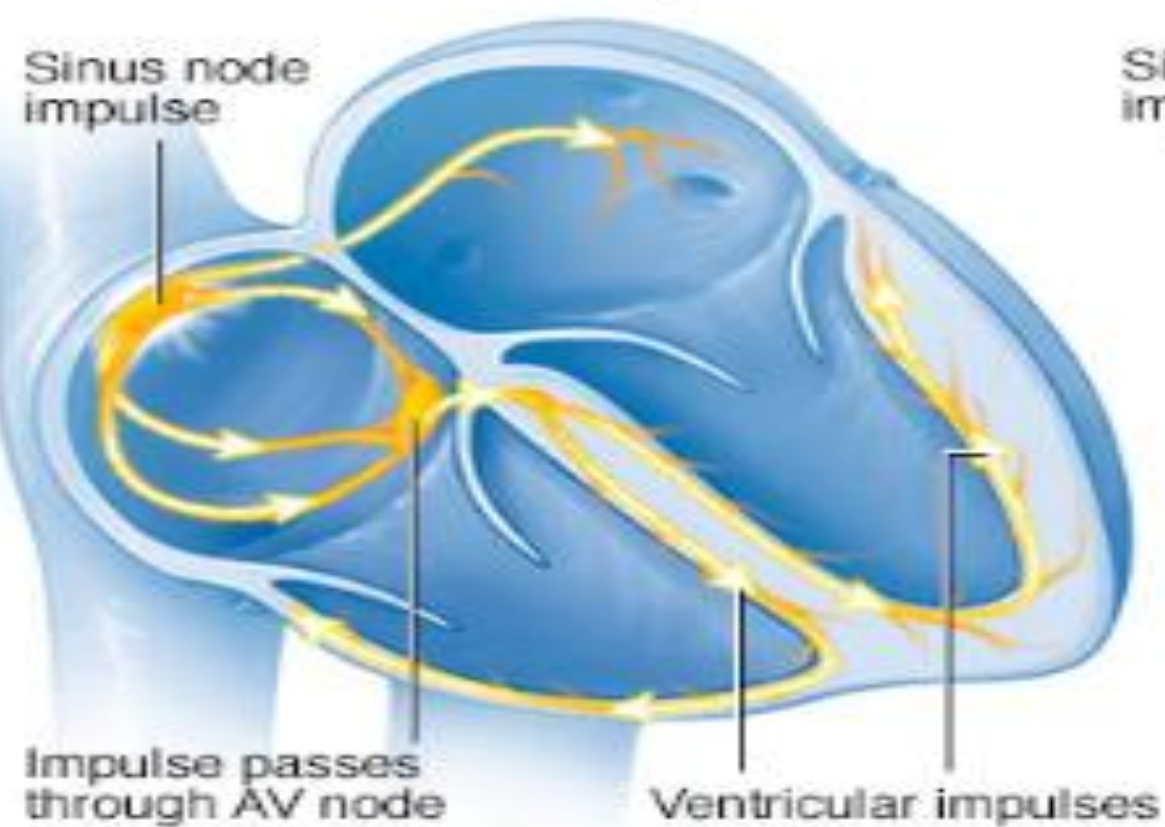
BRADICARDIAS : FC < 50
bpm

A decorative graphic on the left side of the slide featuring a circular, semi-transparent overlay of an ECG (heart rate) waveform on a grid background.

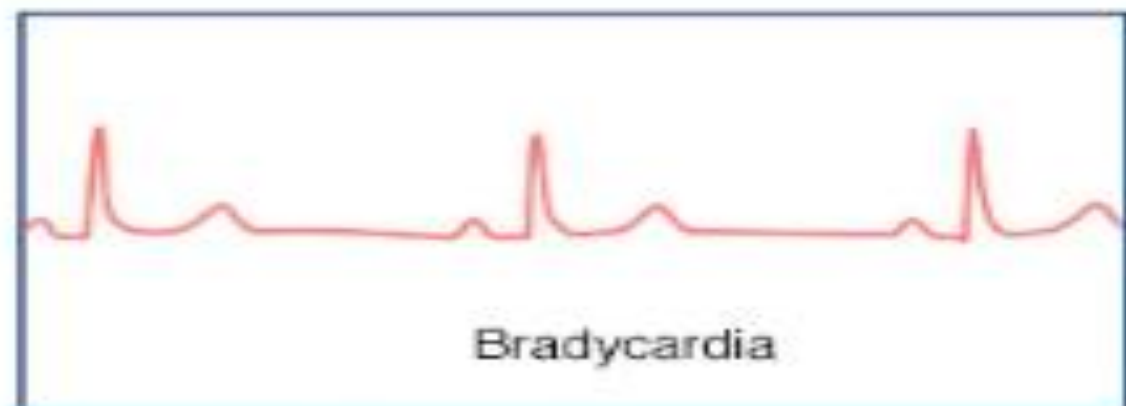
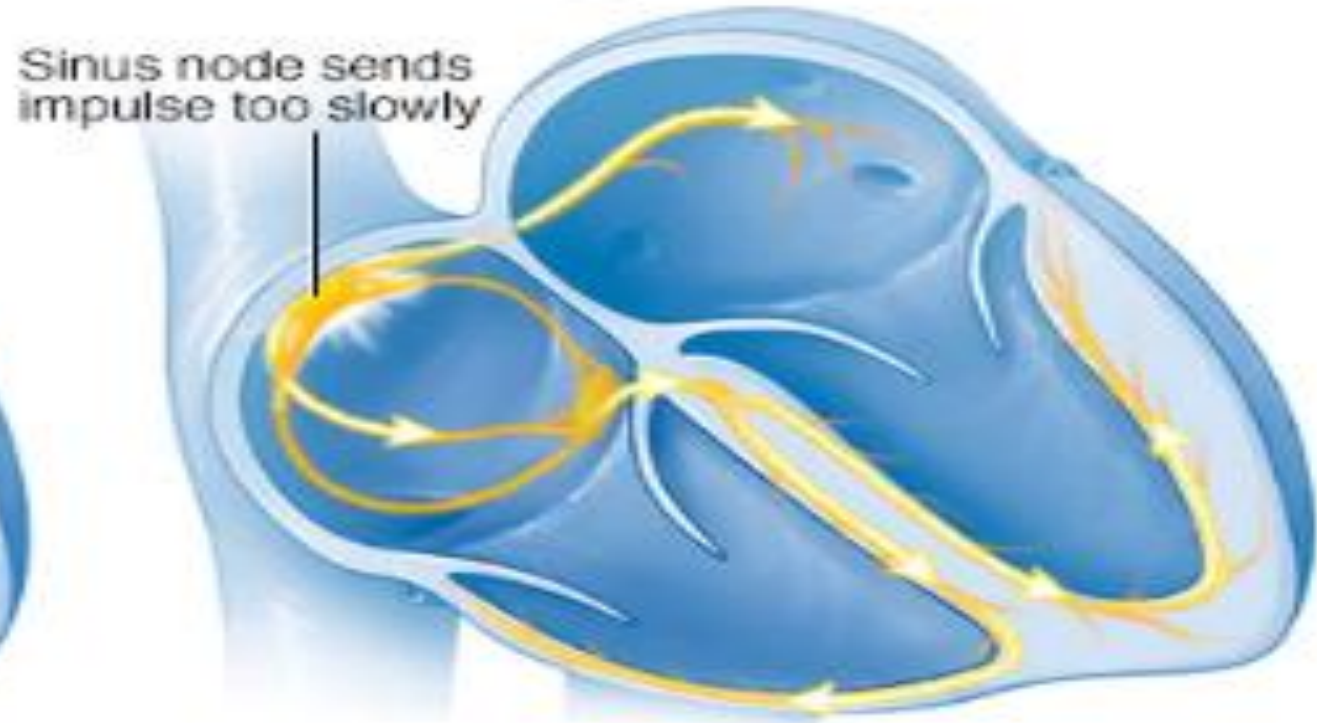
Bradicardia x Bradiarritmia

- Ritmo cardíaco regular FC < 50 bpm (bradicardia)
- Ritmo cardíaco irregular com FC < 50 bpm (Bradiarritmia)
- Bradicardia relativa : FC cardíaca desproporcional à condição clínica do paciente.

Normal heart rhythm



Bradycardia



BRADICARDIAS

AUTONÔMICAS

DOENÇA DO NÓ
SINUSAL

BLOQUEIO
ATRIOVENTRICULAR

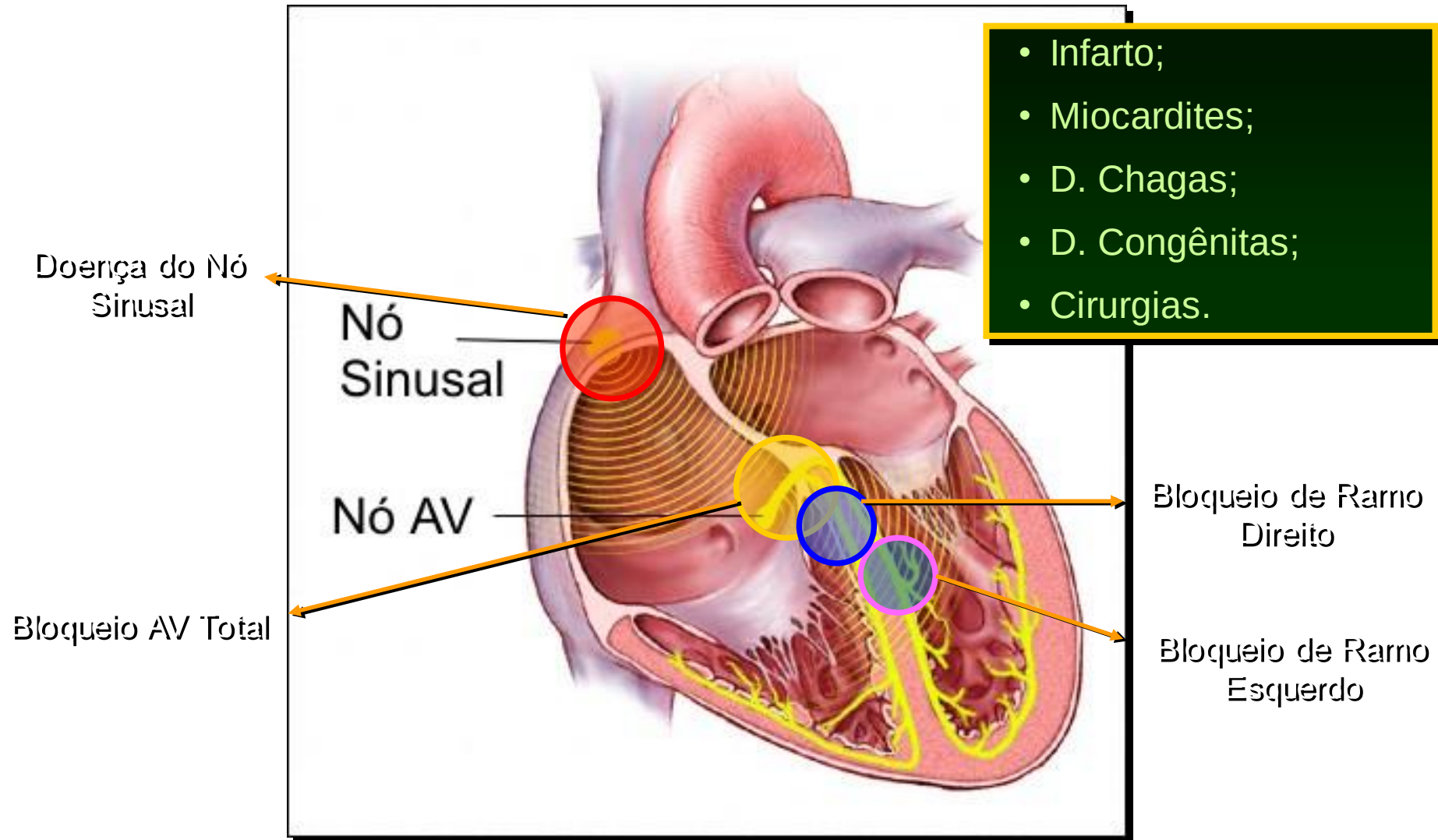
BRADIARRITMIAS

MECANISMO ELETROFISIOLOGICO:

- Alterações do impulso elétrico ou atrasos de condução do impulso elétrico pelo Nó atrioventricular / Sistema His-Purkinje
- TIPOS:
 - Bradicardia sinusal
 - Parada sinusal / Pausa sinusal (Bloqueios sinoatrial 2º - tipo I e II ou 3º grau – Ritmo de escape)
 - ❖ Doença do Nó sinusal (BS – BSA – Ritmo de escape, Síndrome bradi Taqui – FA ou Flutter atrial)
 - ❖ Bloqueios Atrioventriculares **BAV** : 1º - 2º (tipo I e tipo II ou 2:1) - Avançado - 3º (completo)



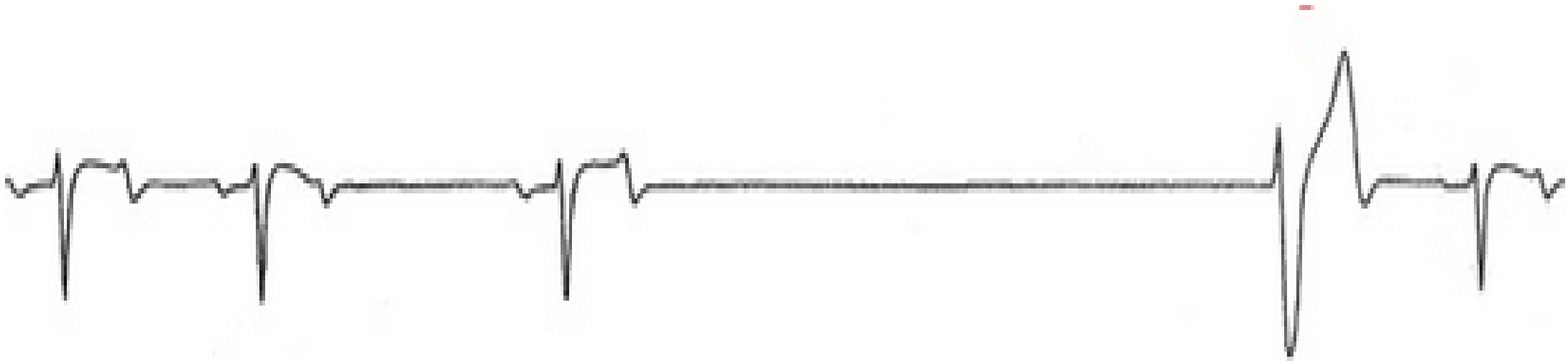
Alterações do Ritmo Cardíaco



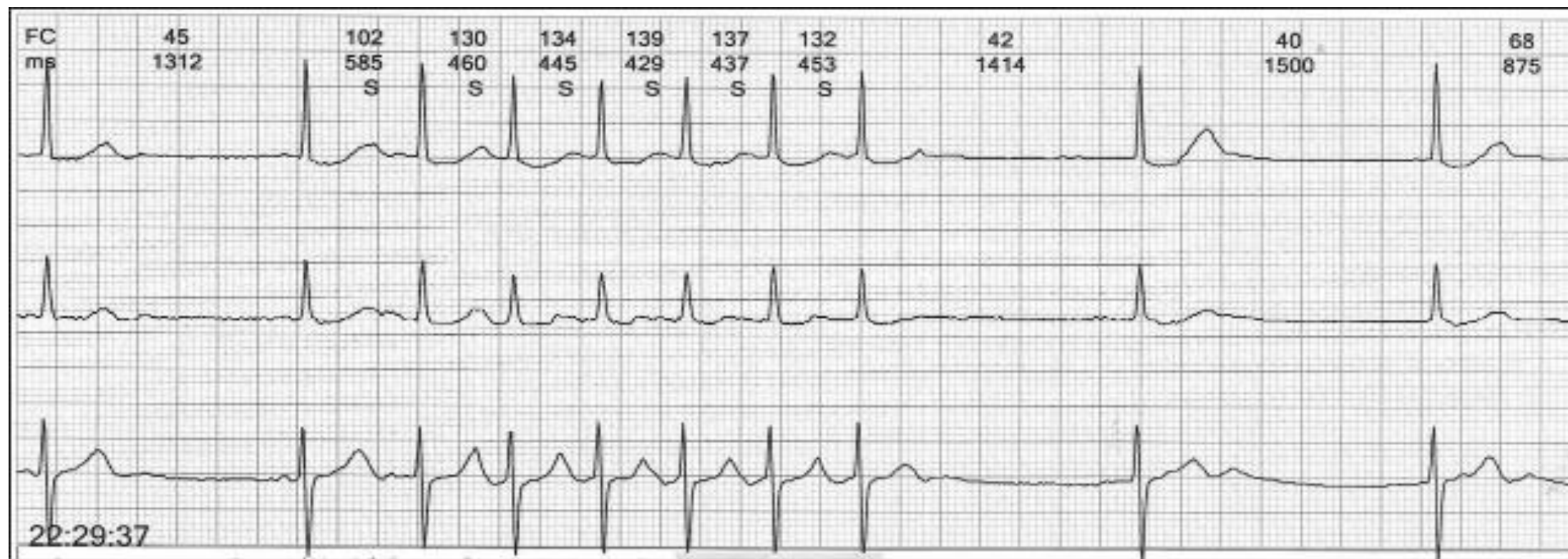
PAUSAS / PARADA SINUSAL



PAUSAS SINUSAL - RITMO DE ESCAPE



SINDROME BRADI - TAQUI



BAV 1º grau



BAV 2º GRAU

Mobitz I or Wenckebach



Mobitz II



2:1 block

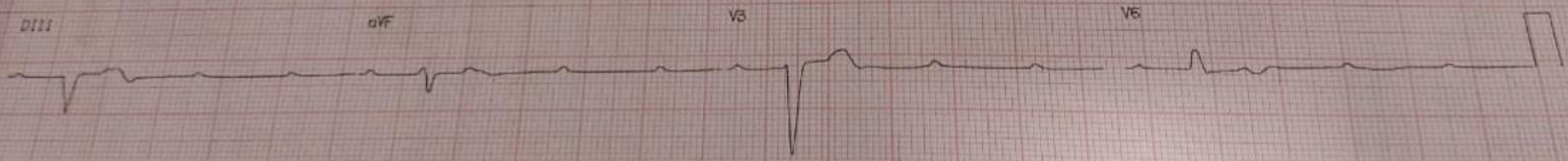
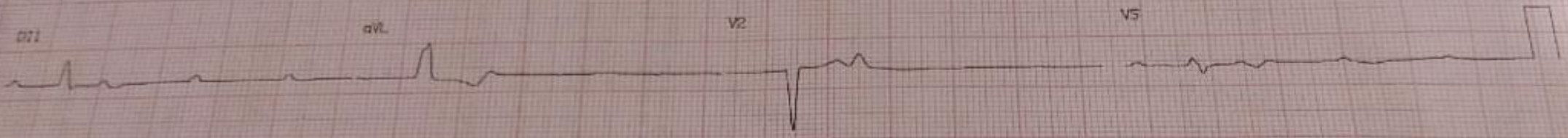
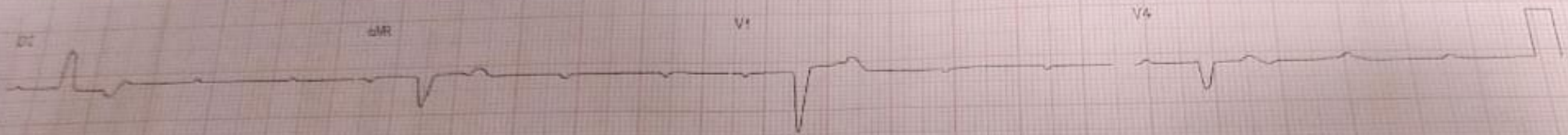


BAV TOTAL – 3º GRAU - BAVT

❖ Dissociação átrio ventricular

10117

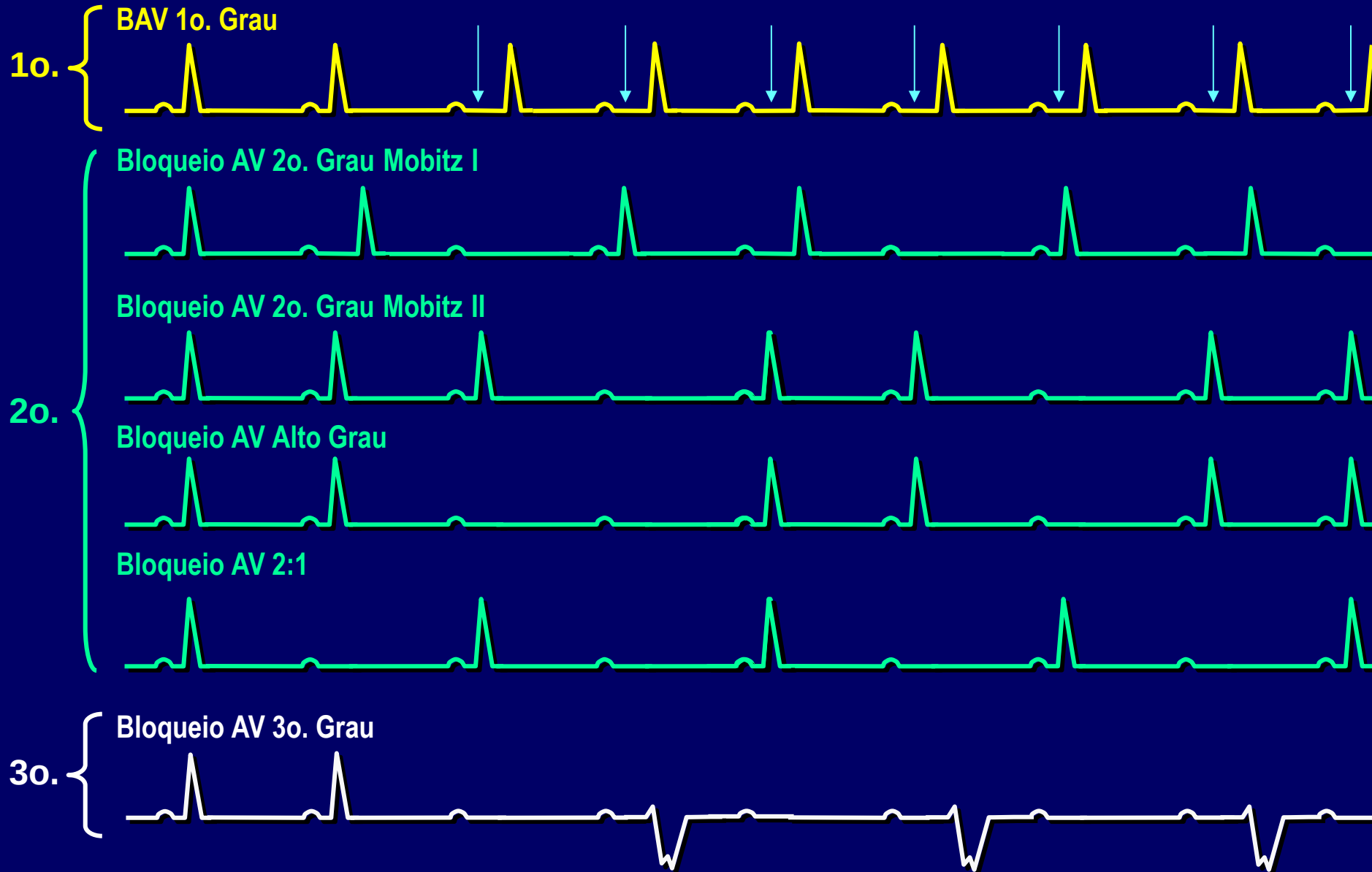
CA
KATIAG



34 bpm 25.0 mm/s N F+ 50 0.5 - 25 Hz

TIT

Tipos de Bloqueios AV



CONDUTA- TRATAMENTO?

- DEPENDE DA CAUSA – DIAGNÓSTICO
- ATROPINA : 1 mg até no máximo 3 mg EV
- DOPAMINA: 5 mcg/kg/min até 20 mcg/kg/min

Ou

- Adrenalina: 2,5 mcg/kg/min até 10 mcg/kg/min

Ou

- ❖ MARCA PASSO CARDÍACO TRANSCUTANEA → MARCA PASSO CARDÍACO TRANSVENOSO.

Bradycardias – CONDIÇÕES CLÍNICAS

INSUFICIÊNCIA RENAL

TIREOIDEOPATIAS

DOENÇAS CEREBROVASCULARES

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA

IAM DE PAREDE INFERIOR

DOENÇA DE CHAGAS

ENVELHECIMENTO

MEDICAÇÕES

EXTRASSISTOLES SUPRAVENTRICULARES OU VENTRICULARES

Bradycardias – Distúrbios Hidroeletrolíticos

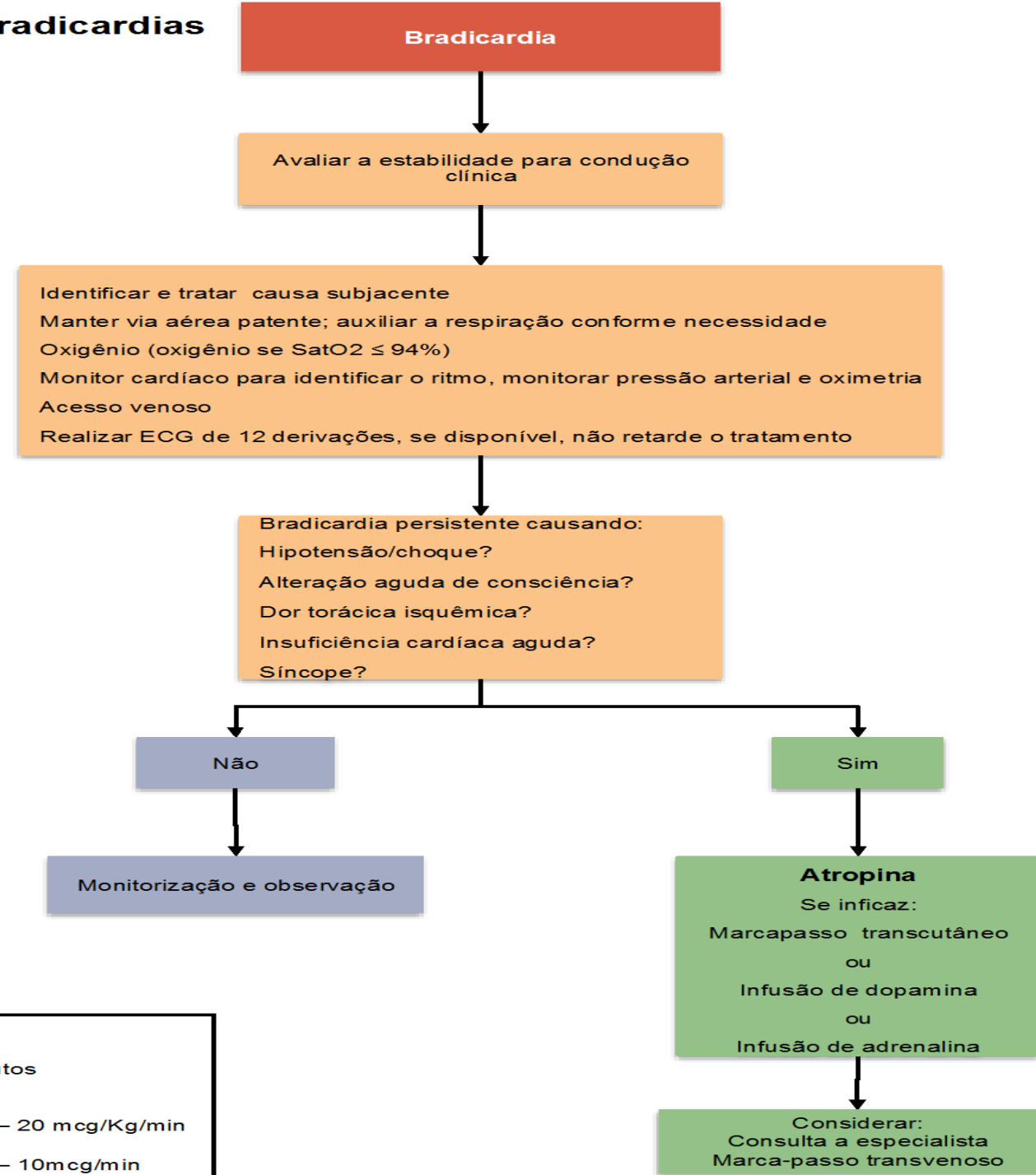
HIPERCALEMIA

ACIDOSE

HIPERCALCEMIA

HIPERMAGNESEMIA

Algoritmo das Bradicardias



Dose Atropina IV:
0,5 mg em bolus
Repetir a cada 3 – 5 minutos
Dose máxima: 3 mg
Dopamina IV
Velocidade de infusão: 2 – 20 mcg/Kg/min
Epinefrina IV:
Velocidade de infusão: 2 – 10mcg/min

PA

DEITO

